

БЕКТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары жана
медициналык буюмдар
департаментинин директорунун
орун басары

Абдиев М. К.

« 7 »

сентябрь

2022-ж.

**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

ЖАСМЕД

Соодадагы аталышы: Жасмед

Эл аралык патенттелбеген аталышы: азитромицин

Дарынын түрү: жука чел кабык капталган таблеткалар

Курамы: жука чел кабык капталган ар бир таблетка төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү заттар:

Азитромицин USP (дигидрат түрүндө)

суусуз азитромицинге туура келет 250 мг

Көмөкчү заттар: микрокристаллдуу целлюлоза (О), суусуз коллоиддүү кремний диоксиди, натрий крахмалгликоляты (А тиби), повидон (PVP K-30), жүгөрү крахмалы, жүгөрү крахмалы (паста үчүн), микрокристаллдуу целлюлоза (РН 112), суусуз коллоиддүү кремний диоксиди, тазартылган тальк, магний стеараты, натрий крахмалгликоляты (А тиби), гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), тазартылган тальк, макроголдор (ПЭГ-6000), титан диоксиди, сары хинолин боёгучу, суусуз коллоиддүү кремний диоксиди.

Сүрөттөмөсү: Бир тарабында сызыгы бар, эки жагы томпок, сүйрү, сары түстөгү жука чел кабык капталган таблеткалар.

Фармакодарылык тобу: Системалуу колдонуу үчүн микробго каршы препараттар. Системалуу колдонуу үчүн бактерияга каршы препараттар. Макролиддер, линкозамиддер жана стрептограминдер. Макролиддер. Азитромицин.

АТХ коду: J01FA10.

Фармакологиялык таасири:

Фармакодинамикасы:

Кеңири чөйрөдө таасир берүүчү антибиотик. Антибиотик-азалид, макролиддик антибиотиктердин өкүлү. Сезгенүү очогунда жогору концентрацияларын түзүүдө бактерициддик таасир көрсөтөт.

Азитромицинге сезгич грам оң кокктор: *Streptococcus pneumoniae*, *St. pyogenes*, *St. agalactiae*, CF жана G тобундагы стрептококктор, *Staphylococcus aureus*, *St. viridans*; грам терс бактериялар: *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Bordetella pertussis*, *B. parapertussis*, *Legionella pneumophila*, *H. ducrei*, *Campylobacter jejuni*, *Neisseria gonorrhoeae* жана *Gardnerella vaginalis*; кээ бир анаэробдук микроорганизмдер: *Bacteroides bivius*, *Clostridium perfringens*, *Peptostreptococcus spp*; ошондой эле *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Ureaplasma urealyticum*, *Treponema pallidum*, *Borrelia burgdoferi*. Азитромицин эритромицинге туруктуу грам оң бактерияларга карата активдүү эмес.

Фармакокинетикасы:

Ичкенден кийин азитромицин жакшы сиңет жана организмде тез бөлүштүрүлөт. 500 мг бир жолу ичкенден кийин биожеткиликтүүлүгү боор аркылуу биринчи өтүү таасиринин эсебинен 37% түзөт. Кан плазмасынын C_{max} 2-3 сааттан кийин жетет жана 0,4 мг/л түзөт.

Белоктор менен байланышуусу кан плазмасындагы концентрацияга кайтарым пропорционалдуу жана 7-50% түзөт. Көрүнгөн V_d 31,1 л/кг түзөт. Клеткалардын мембраналары аркылуу кирет (клетка ичиндеги козгогучтардан пайда болгон инфекцияларда натыйжалуу). Инфекциянын ордуна фагоциттер менен транспорттолот, ал жерде бактериялардын катышуусунда бошонот. Гистогематикалык тосмолор аркылуу жеңил өтөт жана ткандарга келет. Ткандардагы жана клеткалардагы концентрациясы плазмадагыга салыштырмалуу 10-50 эсе жогору, ал эми инфекциянын очогунда дени-сак ткандарга салыштырмалуу 24-34%га жогору. Активдүүлүгүн жоготуу менен боордо деметилирленет. $T_{1/2}$ узак - 35-50 саат. Ткандардан $T_{1/2}$ олуттуу жогору. Азитромициндин дарылык концентрациясы акыркы дозаны ичкенден кийин 5-7 күнгө чейин сакталат. Азитромицин негизинен өзгөрүлбөгөн түрдө - 50% ичеги, 6% бөйрөктөр аркылуу бөлүнүп чыгат.

Колдонууга көрсөтмө:

- өнөкөт бронхиттин курчушу;
 - ооруканадан тышкары пневмония (жеңилден орточо оор формасына чейин);
 - курч бактериялык синусит;
 - фарингит, тонзиллит;
 - курч бактериялык ортоңку отит;
 - жеңилден орточо оор формага чейин тери жана жумшак ткандардын инфекциялары;
 - *Chlamydia trachomatis* пайда болгон татаалдашпаган уретрит жана цервицит.
- Бактерияга каршы дары препараттарын туура колдонууга тиешелүү көрсөтүлгөн дарылык сунуштар милдеттүү түрдө сакталууга тийиш.

Каршы көрсөмө:

- азитромицинге, эритромицинге, макролиддер тобундагы башка антибиотиктерге же кетолиддик антибиотиктерге, препараттын көмөкчү заттарынын кайсы бирине жогору сезгичтик;
- дене салмагы 45 кг.дан төмөн балдар.

Кош бойлуулук жана бала эмизүү:

Кош бойлуулукта препаратты, эгерде эне үчүн дарылоодон күтүлгөн потенциалдуу пайда түйүлдүк үчүн мүмкүн болгон коркунучтан жогору болгон учурларда гана колдонулушу мүмкүн.

Препаратты бала эмизүү мезгилинде колдонуу зарылдыгында эне сүтүн эмизүүнү токтотуу керек.

Колдонуу жолу жана дозалары:

Суткасына 1 жолу ичип колдонулат. Таблеткалар тамакка чейин 1 саат мурун же андан 2 сааттан кийин ичилет.

Дене салмагы 45 кг жогору балдар жана өспүрүмдөр жана чоң адамдар, анын ичинде улгайган адамдар: 500 мг күнүнө 1 жолудан 3 күн бою (курстук дозасы 1500 мг).

Chlamydia trachomatis пайда болгон жыныс мүчөлөрүнүн татаалдашпаган инфекцияларында дозасы бир жолку пероралдуу доза түрүндө 1000 мг түзөт. *Neisseria gonorrhoeae* сезгичтер үчүн дарылоо боюнча жергиликтүү клиникалык сунуштарына ылайык, сунушталган дозасы 250 мг же 500 мг цефтриаксон менен айкалышта 1000 мг же 2000 мг азитромицинди түзөт. Пенициллинге жана/же цефалоспориндерге аллергиясы менен жабыркаган бейтаптарга дарылоо боюнча жергиликтүү жетекчилерге кайрылуу керек.

Балдар курагы:

Таблетка формасындагы Жасмед препаратын дене салмагы 45 кг.га чейинки балдар үчүн колдонууга болбойт.

Бөйрөк алсыздыгы:

Жеңил жана орточо оордук даражасындагы бөйрөк алсыздыгы (КК 10–80 мл/мин) бар бейтаптарга дозаны тууралоо талап кылынбайт. Оор бөйрөк алсыздыгы (КК <10 мл/мин) бар бейтаптарга азитромицинди дайындоодо этияттыкты сактоо керек.

Боор алсыздыгы:

Азитромицин боордо зат алмашып, өт менен бөлүнүп чыккандыктан боордун оор оорулары бар бейтаптарга препаратты дайындабаш керек. Мындай бейтаптарды азитромицин менен дарылоо изилдөөлөрү жүргүзүлгөн эмес.

Кыйыр таасирлери:

Кыйыр реакциялардын жыштыгын аныктоо: тез-тез ($> 1/100$ жана $< 1/10$), кээде ($> 1/1000$ жана $< 1/100$), сейрек ($> 1/10\ 000$ жана $< 1/1000$), абдан сейрек ($< 1/10\ 000$).

Кан жаратуу системасы тарабынан: сейрек - тромбоцитопения, нейтропения, эозинофилия.

БНС жана четки нерв системасы тарабынан: кээде – баш айлануу/вертиго, баш оору, уйкусуу, карышуулар; сейрек – сезимдин бузулушу, жалпы алсыздык, уйкусуздук, гиперактивдүүлүк, агрессивдүүлүк, тынчсыздануу, нервоздуулук.

Сезүү органы тарабынан: сейрек – кулактын шулдашы, дүлөйлүккө чейин угуунун калыбына келме бузулушу (узак убакыт бою жогору дозаларда ичүүдө), даамды жана жытты кабыл алуунун бузулушу.

Жүрөк-кан тамыр системасы тарабынан: сейрек – жүрөктүн дүкүлдөшү, аритмия, анын ичинде карынча тахикардиясы, QT аралыгынын узаруусу, эки багыттуу карынча тахикардиясы.

Тамак сиңирүү системасы тарабынан: тез-тез – окшуу, кусуу, ич өтүү, абдоминалдык оорулар жана карышуулар; кээде – ич өтүү, ич көбүү, тамак сиңирүүсүнүн бузулушу, табиттин жоктугу; сейрек – ич катуу, тилдин түсүнүн өзгөрүшү, жалган мембраноздук колит, холестатикалык сарык, гепатит, боор функциясынын лабораториялык көрсөткүчтөрүнүн

маанисинин өзгөрүшү; абдан сейрек – боор функциясынын бузулушу жана боор некрозу (мүмкүн өлүмгө учуратуучу).

Аллергиялык реакциялар: кээде - кычышуу, тери исиркектери; сейрек – ангионевротикалык шишимик, бөрү жатыш, жарыкка сезгичтик, анафилактикалык реакция (сейрек учурларда өлүмгө алып келүүчү), көп формалуу эритема, Стивенс-Джонсон синдрому, токсиндүү эпидермалык некролиз.

Сөөк-булчуң системасы тарабынан: кээде - артралгия.

Заара бөлүп чыгаруу системасы тарабынан: сейрек – чарымдуу нефрит, курч бөйрөк алсыздыгы.

Башкалар: сейрек – кындын сезгениши, кандидоз.

Ашыкча доза:

Симптомдору: окшуу, убактылуу укпай калуу, кусуу, ич өтүү.

Дарылоо: оору белгилерине жараша дарылоо.

Дарылык өз ара таасири:

Антациддик каражаттар азитромициндин биожеткиликтүүлүгүнө таасир бербейт, бирок канда $C_{\max}$ 30%га азайтат, ошондуктан азитромицинди бул препараттарды жана тамакты кабыл алууга жок дегенде, 1 саат мурун же андан 2 сааттан кийин ичүү керек.

Бир убакта колдонууда азитромицин канда карбамазепиндин, диданозиндин, рифабутиндин жана метилпреднизолондун концентрациясына таасир бербейт.

Парентералдуу колдонууда азитромицин айкалышкан дарылоо учурунда кан плазмасындагы циметидиндин, эфаверенздин, флуконазолдун, индинавирдин, мидазоламдын, теofilлиндин, триазоламдын, триметопримдин/сульфаметоксазолдун концентрацияларына таасир бербейт, бирок азитромицинди ичүүгө дайындоодо мындай өз ара таасирдин мүмкүндүгүн жокко чыгарууга болбойт.

Азитромицин теofilлиндин фармакокинетикасына таасир бербейт, бирок башка макролиддер менен бирге ичүүдө кан плазмасындагы теofilлиндин концентрациясы жогорулашы мүмкүн.

Циклоспорин менен бирге колдонуу зарылдыгы болсо, канда циклоспориндин камтылышын көзөмөлдөө сунушталат. Канда циклоспориндин концентрациясынын өзгөрүүсүнө азитромициндин таасири тууралуу маалыматтардын жоктугуна карабастан, макролиддер классынын башка өкүлдөрү кан плазмасындагы анын концентрациясын өзгөртүүгө жөндөмдүү. Дигоксинди жана азитромицинди бирге ичүүдө канда дигоксиндин концентрациясын көзөмөлдөө зарыл, себеби көпчүлүк макролиддер кан плазмасында анын концентрациясын көбөйтүү менен дигоксиндин ичегиде сиңүүсүн жогорулатат.

Варфарин менен бирге ичүү зарыл болсо протромбиндик убакытты дыкат көзөмөлдөө сунушталат.

Терфенадинди жана макролиддер классындагы антибиотиктерди бир убакта ичүү аритмияны жана QT аралыгынын узарышын пайда кылары аныкталган. Ушундан улам, терфенадинди жана азитромицинди бирге ичүүдө бул оорлошуулардын өрчүшүн жокко чыгарууга болбойт. Парентералдуу формадагы азитромициндин CYP3A4 изоферментин басандатышы мүмкүндүгү болгондуктан, циклоспорин, терфенадин, кара көсөө алкалоиддери, цизаприд, пимозид, хинидин, астемизол жана зат алмашуусу бул изоферменттин катышуусу менен

жүргөн башка препараттар менен бирге дайындоодо, ичүү үчүн азитромицинди дайындоодо мындай өз ара таасирдин мүмкүндүгүн эске алуу керек.

Азитромицинди жана зидовудинди бирге ичүүдө азитромицин кан плазмасындагы зидовудиндин фармакокинетикалык параметрлерине же анын жана анын метаболити глюкурониддин бөйрөктөр менен бөлүнүп чыгышына таасир бербейт. Ошондой болсо да, четки кан тамырлардын моноядролук клеткаларында фосфорлонгон зидовудин – активдүү метаболиттин концентрациясы көбөйт. Мындай факттын клиникалык мааниси белгисиз.

Макролиддерди эрготамин жана дигидроэрготамин менен бир убакта ичүүдө алардын токсиндүү таасири билиниши мүмкүн.

Өзгөчө көрсөтмөлөр:

Препараттын бир дозасын ичүүнү өткөрүп жиберген учурларда – өткөрүлгөн дозаны болушунча эртерээк, ал эми кийинкилерин – 24 сааттык тыныгуу менен кабыл алуу керек. Ошондой эле башка антибиотик менен дарылоону жүргүзгөндөй эле Жасмед препараты менен дарылоодо суперинфекциянын (анын ичинде грибоктук) болушу мүмкүн.

Streptococcus pyogenes пайда болгон фарингиттерди/тонзиллиттерди дарылоодо, ошондой эле курч ревматизм калтыратмасын алдын алуу үчүн тандалган препарат адатта пенициллин болуп эсептелет. Мындай учурларда стрептококк инфекцияларына карата Жасмед ошондой эле активдүү, бирок курч ревматизм калтыратмасынын өрчүүсүн алдын алуу үчүн натыйжасыз. Бейтапты кандайдыр бир кыйыр таасирдин пайда болуусу тууралуу дарыгерге билдирүүсү зарылдыгы тууралуу эскертүү керек.

Автоунаа жана механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасири:

Препарат автоунааны айдоо жөндөмдүүлүгүнө жана көңүл буруунун жогору концентрациясын жана психомотордук реакциялардын ылдамдыгын талап кылган башка ишмердүүлүктөргө таасир бербейт.

Чыгаруу формасы:

Ар бир блистерде жука чел кабык капталган 6 таблетка.

Бир блистер медицинада колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон таңгакта.

Сактоо шарты:

Кургак, жарык тийбеген жерде 25°C дан жогору эмес аба табында сакталат.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Жарактуулук мөөнөтү:

3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты:

Дарыгердин рецепти боюнча.

Соода маркасынын жана каттоо күбөлүгүнүн ээси:

NEO UNIVERSE LLP

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park,
London, England, SE10 9QF, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү:

UNIMAX LABORATORIES

Plot No. 7, Sector-24, Faridabad-121005,

Haryana, India (Индия)

Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын (товардын) сапаты боюнча керектөөчүлөрдөн арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги

«Aman Pharm» (Аман Фарм) ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,
Шооруков көч., 36.

Тел: (0312)) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com